

Datos Personales							
Nombre:	ANDREA CAMILA PEDROZO MANRIQUE	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2000-01-28	Edad	26 Años, 0 Meses, Y 29 Días
Identificación:	CC - 1192759097	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Pedrozomanriquea@gmail.Com.Co - 1192759097			Dirección:	Manzana 33 Casa 11 Barrio Villa Miriam		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR			Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		YOSIMAR PEDROZO - Parentesco (hermano) - Teléfono (3022876550)					

Apertura psicología del 2026-02-22 15:14:44: 26 años, 0 meses, y 29 días

DATOS GENERALES

Remisión

Autorreferido (Particular)

DX principal

F431 - TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO

DX Relacionado 1

G470 - TRASTORNOS DEL INICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL SUEÑO [INSOMNIOS]

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

“Estuve hospitaliza en el año 2021 en MENSANA, porque estaba presentando muchos crisis de ansiedad, me aislé de mi familia”.

Enfermedad Actual

La paciente refiere que durante el año 2020 residía sola en la ciudad de Cali, periodo en el cual estuvo expuesta a eventos de alto impacto emocional en el contexto del paro armado, incluyendo presenciar situaciones de violencia, agresiones y muertes de compañeros cercanos. Posterior a dichos acontecimientos, reporta inicio progresivo de sintomatología ansiosa y afectiva.

Durante el año 2021 se evidencia agudización del cuadro clínico, caracterizado por ansiedad intensa, ánimo depresivo, ideación suicida sin conducta autolesiva, hipervigilancia e insomnio de conciliación y mantenimiento, asociado a rumiación persistente en torno a los eventos vividos. En el año 2022 se produce retiro de sus funciones dentro de la institución policial en el marco de su condición de salud mental. Refiere reintegro institucional en octubre de 2025; sin embargo, a la fecha no ha retomado funciones operativas activas debido a persistencia de sintomatología ansiosa residual.

Actualmente, la paciente presenta patrón de sueño irregular, con episodios intermitentes de insomnio, parcialmente modulados con manejo farmacológico. Refiere que los síntomas se reactivan ante recuerdos asociados al contexto traumático previamente vivido.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

Amigdalectomía

Traumáticos

Ninguno

Paraclínicos

Ecografías,RX

Patología

Hipotiroidismo

Tóxicos

Medicación

Eszopiclona 2 Mg.

Hospitalizaciones

Si

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Hipertensión Abuela Materna	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa La paciente cuenta con formación técnica como auxiliar en recursos humanos y formación técnico-profesional en servicio de policía. Durante su trayectoria educativa reporta desempeño académico funcional, sin antecedentes de dificultades cognitivas o de adaptación escolar. Refiere haber mantenido relaciones interpersonales adecuadas en contextos formativos e institucionales.
Historia laboral La paciente inició su ejercicio laboral como patrullera de la Policía Nacional en el año 2020. Presentó suspensión de funciones en el año 2022 debido a afectaciones documentadas en salud mental. Refiere reintegro institucional en octubre de 2025; no obstante, actualmente se encuentra en proceso de reintegración gradual, sin desempeño operativo activo. Durante su trayectoria laboral previa describe relaciones interpersonales funcionales y adecuada adaptación institucional.
Historia familiar La paciente convive actualmente con su abuela materna, la señora Judith Villalobos (67 años), y una tía materna, la señora Liseth Manrique (33 años), así como con la hija menor de esta última (4 años). Describe ambiente familiar estable, con adecuada comunicación y percepción de apoyo emocional. El padre reside de manera independiente y la madre se encuentra radicada en España, manteniendo contacto afectivo a distancia. Refiere un hermano con núcleo familiar propio el señor Jossimarck Pedrozo. En general, la paciente reporta vínculos familiares cercanos y red de apoyo conservada.
Historia social Antes de la exposición a los eventos traumáticos, la paciente refiere que presentaba adecuado funcionamiento social, con rasgos de sociabilidad marcada, iniciativa para la interacción interpersonal y disfrute de actividades sociales. Tras el desarrollo del cuadro compatible con sintomatología postraumática, refiere retraimiento social progresivo, con reducción del disfrute en actividades sociales y evitación relativa de entornos con aglomeraciones.
Historia emocional/afectiva En los ciclos vitales de niñez y adolescencia, la paciente presentó estabilidad afectiva, con adecuada regulación emocional y ánimo eutímico. Tras la exposición a los eventos traumáticos, se evidencia modificación del patrón afectivo, con predominio de sintomatología ansioso-depresiva, asociada a alteraciones del sueño tipo insomnio.
Historia deportiva En la actualidad la paciente realiza actividad física ligera, consistente en caminatas ocasionales. No refiere participación activa en deportes organizados o rutinas de ejercicio estructurado.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial Se realizó evaluación clínica inicial mediante entrevista semiestructurada orientada a la exploración de antecedentes vitales relevantes, áreas de funcionamiento, sintomatología actual, factores de riesgo, funcionamiento premórbido y red de apoyo. Se emplearon técnicas de observación clínica, escucha activa y diálogo socrático, con el objetivo de comprender de manera integral el contexto del caso, así como la naturaleza y severidad de la sintomatología presentada.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica La paciente presenta antecedente de intervención por psiquiatría desde el año 2021, incluyendo hospitalización en la institución Mensana, donde se instauró manejo farmacológico y seguimiento especializado en salud mental. Posteriormente, continuó controles ambulatorios en la institución SION. En la actualidad se encuentra en seguimiento psicológico individual en UNIPSAM y refiere tratamiento farmacológico activo con eszopiclona 2 mg para el manejo del insomnio asociado al cuadro clínico. Dentro de los diagnósticos clínicos reportados se incluyen: - F43.1 Trastorno de estrés postraumático (TEPT) - G47.0 Trastorno del inicio y mantenimiento del sueño (insomnio)
Intervención neurológica No refiere.
Intervención neuropsicológica No refiere.
Otras intervenciones La paciente presenta antecedente de intervención psicológica desde el año 2021, inicialmente en el marco de hospitalización en la institución Mensana. Posteriormente ha continuado en seguimiento psicoterapéutico ambulatorio. En la actualidad se encuentra en proceso de psicoterapia individual en la institución UNIPSAM, con último control reportado el 14 de enero de 2026, evidenciando continuidad en manejo psicológico. La paciente manifiesta que, ante intervalos prolongados entre citas en su red de atención institucional, buscó acompañamiento psicológico particular como apoyo complementario, orientado a mantener continuidad terapéutica. El proceso se enmarca en un abordaje de apoyo clínico, respetando la atención institucional previamente establecida.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

La paciente ingresa a consulta con adecuado saludo y presentación personal acorde al contexto. Se observa vigil, alerta y colaboradora durante la entrevista. Mantiene contacto visual intermitente, con actitud receptiva. Se encuentra orientada autopsíquica, alopsíquica y temporoespacialmente. El lenguaje es fluido, coherente y de curso lógico, sin alteraciones formales del pensamiento. El contenido del discurso se mantiene organizado y congruente con el motivo de consulta. A nivel afectivo, se evidencia tono de voz bajo, con expresión facial triste y afecto de tonalidad disfórica. Refiere sintomatología ansiosa, acompañada de recuerdos sensoriales intrusivos asociados a eventos traumáticos previos. Niega alteraciones senso perceptivas actuales, incluyendo alucinaciones. Refiere antecedentes de ideación suicida sin conductas autolesivas, sin ideación suicida activa al momento de la valoración. No se evidencian alteraciones cognitivas durante la entrevista; la atención y memoria inmediata se encuentran conservadas en la evaluación clínica. Juicio y capacidad de introspección conservados. La paciente reconoce su estado emocional actual y la necesidad de acompañamiento terapéutico.

Ciclos del Sueño

Se identifican alteraciones del patrón de sueño, principalmente insomnio de conciliación y mantenimiento.

Apetito

Conservado.

Actividades de Autocuidado

Independiente.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F431 - TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO

Impresión Diagnóstica Relacionada 1

G470 - TRASTORNOS DEL INICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL SUENO [INSOMNIOS]

Impresión Diagnóstica Relacionada 2

NREF - NO REFIERE

Establecido por primera vez

No

Objeto de atención clínica

NO REFIERE

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Favorecer la regulación emocional y funcional de la paciente mediante intervención psicoterapéutica orientada al manejo de sintomatología ansiosa y postraumática, fortalecimiento de recursos de afrontamiento y prevención de recaídas asociadas a reexposición a factores desencadenantes.

Objetivos Específicos

- Disminuir la intensidad y frecuencia de sintomatología ansiosa mediante estrategias de regulación emocional basadas en evidencia.
- Abordar progresivamente los recuerdos intrusivos asociados a eventos traumáticos, favoreciendo procesamiento emocional seguro.
- Mejorar la calidad del sueño mediante psicoeducación en higiene del sueño y técnicas de regulación fisiológica.
- Fortalecer habilidades de afrontamiento adaptativas ante estímulos asociados a trauma.
- Reducir conductas evitativas y favorecer reintegración funcional gradual en contextos cotidianos.
- Promover estabilidad emocional mediante fortalecimiento de red de apoyo y factores protectores.
- Prevenir recaídas clínicas mediante seguimiento terapéutico continuo y detección temprana de signos de descompensación.

Sugerencias e Interconsultas

- **Psiquiatría:** Para seguimiento farmacológico y ajuste de medicación en caso de persistencia de alteraciones del sueño o agudización sintomática.
- **Medicina general:** Para monitoreo integral de salud física asociada a trastornos del sueño o somatización.

Observaciones y Recomendaciones

OBSERVACIONES CLÍNICAS

- La paciente presenta antecedente de trastorno de estrés postraumático con curso crónico y sintomatología residual activa.
- Se evidencia necesidad de continuidad terapéutica sostenida para evitar recaídas clínicas.
- La estabilidad emocional actual se encuentra parcialmente mediada por acompañamiento psicológico y manejo farmacológico vigente.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

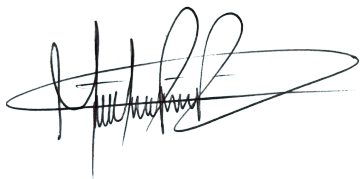
- Mantener continuidad en el proceso psicoterapéutico sin interrupciones prolongadas.
- Evitar cambios abruptos en el entorno que puedan reactivar memorias traumáticas.
- Favorecer ambientes emocionalmente seguros que faciliten estabilización clínica.
- Mantener adherencia a manejo farmacológico según indicación médica.
- Fortalecer red de apoyo familiar como factor protector.
- Realizar seguimiento periódico del estado emocional y calidad del sueño.

CONCEPTO CLÍNICO COMPLEMENTARIO

Dada la naturaleza del cuadro clínico y la relación directa entre la sintomatología y el contexto donde ocurrieron los eventos traumáticos, se recomienda preservar condiciones de estabilidad psicosocial y continuidad terapéutica, evitando exposiciones que puedan favorecer reactivación sintomática.

ENFOQUE TERAPÉUTICO SUGERIDO

- Psicoterapia individual: semanal según evolución clínica.
- Terapia cognitivo-conductual centrada en trauma
- Técnicas de regulación emocional
- Psicoeducación en trauma
- Intervenciones basadas en mindfulness (según tolerancia)
- Acompañamiento psicoterapéutico continuo
- Reevaluación periódica del estado emocional y funcional.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica

Tarjeta Profesional: 259542

Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER

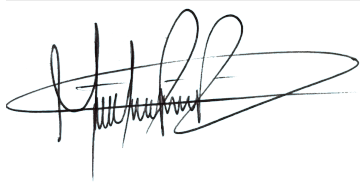
Datos Personales							
Nombre:	ANDREA CAMILA PEDROZO MANRIQUE	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2000-01-28	Edad	26 Años, 0 Meses, Y 29 Días
Identificación:	CC - 1192759097	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Pedrozomanriquea@gmail.Com.Co - 1192759097			Dirección:	Manzana 33 Casa 11 Barrio Villa Miriam		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		YOSIMAR PEDROZO - Parentesco (hermano) - Teléfono (3022876550)					

Impresión Diagnóstica:
F431 - TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO

Impresión Diagnóstica Relacionada 1
G470 - TRASTORNOS DEL INICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL SUENO [INSOMNIOS]

Impresión Diagnóstica Relacionada 2
NREF - NO REFIERE

ÓRDENES MÉDICAS		
No.	PROCEDIMIENTO	CANTIDAD
1	890384 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA OBSERVACIÓN: Para Seguimiento Farmacológico Y Ajuste De Medicación En Caso De Persistencia De Alteraciones Del Sueño O Agudización Sintomática.	1
2	890301 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL OBSERVACIÓN: Para Monitoreo Integral De Salud Física Asociada A Trastornos Del Sueño O Somatización.	1



PRASCA
CENTER

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica

Tarjeta Profesional: 259542

Mag. TP3G - VIU